

Guia Sustitucion Antihipertensivos

Guía de Sustitución de Antihipertensivos

Versión: 2.1 | Julio 2025

1. Introducción

Esta guía establece los criterios para la sustitución segura de medicamentos antihipertensivos en situaciones de desabastecimiento. Aplica para todas las farmacias del grupo hospitalario.

2. Principios Generales

Toda sustitución debe ser aprobada por el servicio de farmacia.

Se debe verificar ausencia de alergias del paciente antes de sustituir.

Ajustar dosis según función renal del paciente.

Documentar toda sustitución en el sistema de historia clínica.

3. Tabla de Sustituciones por Grupo Terapéutico

3.1 IECA (Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina)

Medicamento Base	Alternativa 1	Alternativa 2	Ajuste Renal
------------------	---------------	---------------	--------------

---	---	---	---
-----	-----	-----	-----

Enalapril 5 mg	Lisinopril 5 mg	Ramipril 2.5 mg	Reducir 50% si CrCl <30
Enalapril 10 mg	Lisinopril 10 mg	Ramipril 5 mg	Reducir 50% si CrCl <30
Enalapril 20 mg	Lisinopril 20 mg	Ramipril 10 mg	Reducir 50% si CrCl <30
Captopril 25 mg	Enalapril 5 mg	Lisinopril 5 mg	Reducir dosis si CrCl <30
Captopril 50 mg	Enalapril 10 mg	Lisinopril 10 mg	Reducir dosis si CrCl <30

3.2 ARA II (Antagonistas del Receptor de Angiotensina II)

Medicamento Base	Alternativa 1	Alternativa 2	Ajuste Renal
---	---	---	---
Losartán 50 mg	Valsartán 80 mg	Irbesartán 150 mg	No requiere ajuste
Losartán 100 mg	Valsartán 160 mg	Irbesartán 300 mg	No requiere ajuste
Valsartán 80 mg	Losartán 50 mg	Irbesartán 150 mg	No requiere ajuste
Valsartán 160 mg	Losartán 100 mg	Irbesartán 300 mg	No requiere ajuste
Olmesartán 20 mg	Losartán 50 mg	Valsartán 80 mg	No requiere ajuste

3.3 Bloqueadores de Canales de Calcio

Medicamento Base	Alternativa 1	Alternativa 2	Ajuste Renal
---	---	---	---
Amlodipino 5 mg	Nifedipino 30 mg	Felodipino 5 mg	No requiere ajuste
Amlodipino 10 mg	Nifedipino 60 mg	Felodipino 10 mg	No requiere ajuste
Nifedipino 30 mg	Amlodipino 5 mg	Felodipino 5 mg	No requiere ajuste

3.4 Betabloqueadores

Medicamento Base	Alternativa 1	Alternativa 2	Ajuste Renal
---	---	---	---
Atenolol 50 mg	Metoprolol 50 mg	Bisoprolol 5 mg	Reducir 50% si CrCl <30
Atenolol 100 mg	Metoprolol 100 mg	Bisoprolol 10 mg	Reducir 50% si CrCl <30
Metoprolol 50 mg	Atenolol 50 mg	Bisoprolol 5 mg	No requiere ajuste
Propranolol 40 mg	Atenolol 50 mg	Metoprolol 50 mg	No requiere ajuste

4. Contraindicaciones Generales para Sustitución

Alergia conocida al grupo farmacológico.

Angioedema previo con IECA (no sustituir por otro IECA, usar ARA II).

Embarazo: evitar IECA y ARA II. Usar metildopa o labetalol.

Insuficiencia renal severa ($\text{CrCl} < 15$): preferir ARA II sobre IECA.

Hiperpotasemia severa ($\text{K}^+ > 5.5$): evitar IECA y ARA II.

5. Procedimiento en Caso de Desabastecimiento

Verificar el desabastecimiento en el sistema de gestión de farmacia.

Consultar la tabla de sustitución correspondiente al grupo terapéutico.

Evaluar condiciones del paciente: alergias, función renal, embarazo.

Seleccionar la alternativa más adecuada según la tabla.

Registrar la sustitución en el sistema y notificar al médico prescriptor.

Realizar seguimiento del paciente a los 7 días para verificar eficacia.

6. Contactos

Servicio de Farmacia: farmacia@hospital-ejemplo.com | Ext. 4501

Comité de Farmacoterapia: farmacoterapia@hospital-ejemplo.com | Ext. 4502

Dirección Médica: dir.medica@hospital-ejemplo.com | Ext. 4100

Documento aprobado por el Comité de Farmacoterapia. Próxima revisión: Enero 2026.